# ICUの臨床倫理と終末期の意思決定

価値観を聴いてから、医師が提案する

聖路加国際病院 集中治療科

# 今日持ち帰る3つ

1

**DNARは、心停止時のCPRだけを決める**
治療の範囲は多職種の検討と共同意思決定で決め、迷えば期限付きで試す

2

**価値観を聴いてから、医師が推奨する**
選ばせない。決定の重荷を家族に負わせない

3

**終えるときは、苦痛に先回りする**
緩和ケアを先に準備し、家族とチームを支える

はじめに

# 倫理は、
# 毎日の判断の中にある

特別な症例のときだけの話ではない

聖路加国際病院 集中治療科

# この聞き方、していませんか

### 「心臓マッサージは希望しますか」

価値観を聴く前に、処置の希望を聞く

### 「DNARなので挿管はしません」

心停止前の治療まで、自動的に控える

### 「ご家族で決めてください」

決断の重さを、家族に預けてしまう

どれも悪意はない。**聴く順番と、DNARの範囲**がずれている

第 1 章

# 01

# 前提をそろえる

なぜ大事か・言葉・中心原則

# ICUの死の多くは、「決めた後」に起きる

**89.7%**

治療制限を伴う死
（1999年は68.3%）

**20.4%**

治療制限を受けた後に、
生存して退院（同 5.5%）

**34.9%**

差し控えた後に限ると、3人に
1人が退院

**治療制限は看取りの開始ではなく、ゴールの定義し直し。決め方が結果を左右する**

出典：Ethicus-2（Sprung JAMA 2019、欧州22 ICU・2015〜16年）

# 2026年の基準線は、手順で決めること

| 項目 | 2014年（3学会の提言） | 2026年（4学会合同GL） |
|---|---|---|
| **終末期** | 定義し、4つの例示 | **あえて定義しない** |
| **決め方** | チームが終末期と判断 | 多職種の検討＋共同意思決定 |
| **差し控えと終了** | — | 倫理的に同等。TLTを明記 |
| **緩和ケア** | 「緩和的措置」の一言 | 別編で薬・家族・医療者のケア |

**法律はない。手順を踏み、過程を記録することが法的な不安への答え**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）本編・説明文

# 同じ言葉を、同じ意味で使う

| 用語 | 定義・使い方 | 避ける言い方 |
|---|---|---|
| **DNAR** | 心停止時にCPRを試みない指示。<br>**心停止時だけ**有効 | 「急変時DNR」 |
| **差し控え／終了** | 始めない／やめる。倫理的に同等 | 「治療中止」 |
| **終末期** | 4学会GLは定義しない。ゴールから判断する | 「終末期なので」 |
| **推定意思** | 本人ならどう考えるか。家族の希望と区別する | 「家族がDNARを希望」 |
| **BSC・延命治療** | 使わない。何を続け、何を終えるかを書く | 「BSCで」 |

出典：4学会合同ガイドライン（2026）、日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、日本救急医学会 用語の統一概念（2025）

# 中心原則：選ばせずに、医師から提案する

**相手に選ばせず、医師から提案する。**

ただし、状況に応じて提案の強さを変える。

1
病状を伝える

→

2
価値観を聴く

→

3
専門家として
推奨する

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020（3ステージ）、AHA 2025 倫理編

# 提案と誘導を分けるのは、価値観を聴いたかどうか

| | | | |
|---|---|---|---|
| 価値観を聴かずに | → | 「CPRはしないほうがいい」 | → 誘導 |
| **価値観を聴いた** 「もう苦しみたくない」 | → | 「CPRはしないほうがいい」 | → 提案 |

同じ言葉でも、順番で意味が変わる。提案は**価値観を医療行為に翻訳**すること

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020、Elwyn BMJ 2010

# 提案の強さは、5段階

| | | | |
|---|---|---|---|
| ●●●●● | **informed assent** | **「○○はしません」** | 無益が明らかで、<br>価値観もはっきり |
| ●●●●○ | **informed nondissent** | **「反対があれば、おっしゃってください」** | 拒否権を明示して残す |
| ●●●○○ | **推奨して意見を求める** | **「しないほうがいいと思います」** | 推奨ははっきり、<br>決定は一緒に |
| ●●○○○ | **やや弱い推奨** | **「おすすめしません」** | 医学的な見込みに幅が<br>あるとき |
| ●○○○○ | **使わない** | **「○○はどうしますか」** | ゴールに<br>寄与しないなら、<br>丸投げになる |

強い：医療者が重さを引き受ける　　弱い：決断を相手に預ける

出典：Curtis JAMA 2020（informed assent）、AHA 2025 倫理編（informed nondissent）

# 強さを選ぶ、3つの要素

1

**医学的な確かさ**
利益がないことが、どこまで明らかか

2

**価値観の明確さ**
本人が何を大切にするかが、聴けているか

3

**委ねたい気持ち**
家族が決定を医療者に委ねたいか。**強い形の前に確かめる**

**そろわなければ強さを下げる。提案の前に聴き直す**

出典：AHA 2025 倫理編、Curtis JAMA 2020

第 2 章

# 02

# 誰がどう決めるか

枠組み・意思決定能力・2本柱

# 4原則は、ぶつかる価値に名前をつける

## 自律尊重

本人が自己決定する権利

例：本人が挿管を拒む、事前指示がある

## 善行

本人に最大の利益をもたらす義務

例：見込みの不確かな治療を始めるか

## 無危害

利益のない治療で害を与えない義務

例：苦痛を伴うだけの処置、無益なCPR

## 公正

すべての患者を公平に扱う義務

例：ベッドの配分、障害や年齢による無自覚な差

**「全部やって」は、家族の希望と無危害がぶつかっている、と言い換えるだけで議論が進む**

出典：FCCS（倫理の章）

# 4分割法で、症例をもれなく並べる

### 医学的適応
診断と予後、治療の目標、成功の可能性、
失敗したときの対応

### 患者の意向
本人の希望、意思決定能力、事前の意思表示、
代理は誰がどの基準で

### QOL
元の生活に戻る可能性、評価者のバイアス、
緩和ケアの予定

### 周囲の状況
家族、医療者側の問題、経済・宗教・文化、
資源、法律

**4つの窓を全部埋めてから議論する。埋まらない窓が、次に集める情報**

出典：Jonsen の4分割表。4学会GLの「臨床倫理的検討の4観点」も同じ骨格

# 意思決定能力は、決定ごとに評価する

① 選択を伝えられる

② 理解する

③ 自分のことと
して認識する

④ 比較して考えられる

- 全か無かではない。**医学的助言に反する選択**だけでは能力欠如の根拠にならない
- 鎮静・せん妄で能力は時間で動く。**清明な時間**に合わせる
- 「能力なし」とだけ書かず、決定・時刻・欠けた過程を書く

出典：Ganzini JAMDA 2004、4学会合同ガイドライン（2026）Q16

# 一人で決めない：2本柱で検討し、3つから選ぶ

### 柱1 チームの臨床倫理的検討

4観点をもれなく。関わる診療科・多職種・かかりつけ医まで、**全員に発言の機会**を

### 柱2 本人・家族等との共同意思決定

厚労省プロセスガイドラインに沿う。価値観を聴いてから推奨する

**差し控え**
始めない

**終了**
症状緩和のみ、または一部

**TLT**
期限付きで試す

**決まらなければ倫理コンサルへ。ただし決定は代行させない**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）。どれを選んでも心停止時のCPRは行わず、症状緩和は続ける

# 代理の人には「ご本人ならどう言うか」を聞く

| 場面 | 進め方 |
| --- | --- |
| **本人の意思を確認できる** | 能力を評価し、説明して合意する |
| **確認できないが推定できる** | 家族等とチームが推定した意思を尊重する |
| **推定もできない** | 家族等と話し合い、本人にとって最善の方針をとる。状態が変わるたびに繰り返す |
| **身寄りがない** | 過去の意向を最大限尊重し、チームと倫理委員会が透明な手続きで判断する |

> **問うのは「ご家族はどうしたいか」ではなく「ご本人ならどう考えるか」**

出典：厚労省プロセスガイドライン（2018）、4学会合同ガイドライン（2026）Q6・Q18

# 予後の数字は情報、決定は価値観で

「偽陽性ゼロ」でも

**10.6%**

良好転帰が33例なら、真の偽陽性率は95%の確からしさで**ここまで**しか言えない

「反応がない」でも

**15〜25%**

急性脳損傷で反応のない人に、検査でしか分からない**隠れた意識**がある

**重症度スコアや予後モデルを、治療制限の理由としてカルテに書かない**

出典：Bein ICM 2023、Xu Crit Care 2026、Cho Crit Care 2026、Egawa J Intensive Care 2024

# 違和感と先入観を、チームで点検する

**26%**

「不適切な治療をしている」と感じていた医療者。複数人が一致した患者は6か月死亡

**aOR 3.86**

違和感は予後のシグナル。ゴールを見直すきっかけにする

**18%** 医療者の予想　**92%** 生存者本人

重い脊髄損傷のあと「生きていてよかった」。医療者の推定するQOLはあてにならない

**「この人はどうせ」を前提にしない。本人に聞く**

出典：PICNL-ICU（CCM 2026、オランダ47 ICU・1,058人）、Gerhart Ann Emerg Med 1994、Taccone ICM 2023

第 3 章

# 03

# 聴いてから話す

ACP・面談の型・家族の重荷

ACPとGoals of Care

# 選択肢から始めると、生死の二択になる

先に、何を大切にしてきたかを聴く

聖路加国際病院 集中治療科

# 病状 → 価値観 → 推奨の3段で話す

Stage 1
**病状を伝える**
予後をはっきりと。
医療者が主

→

Stage 2
**価値観を聴く**
楽しみ・生きがい・
悪くなったときの気が
かり。**本人・家族が主**

→

Stage 3
**推奨する**
価値観を医療行為に
翻訳して提案。
医療者が主

**いちばん多い失敗は、Stage 2 を飛ばして Stage 3 の選択を迫ること**

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020、Secunda J Gen Intern Med 2020

# ACPは書類ではなく、価値観の共有

**48%**

事前指示書が効く7条件が、それぞれ**90%**で
そろっても、全部そろう確率

- 書類が「もう話さなくてよい」を
  生むこともある
- 根幹は、本人が価値観を言えること
- 代理人1人より、**多くの
  家族と共有**しておく
- ICUの制限カンファで事前指示があった
  患者は**0名**

**ACPは、イベントではなく繰り返すプロセス**

出典：厚労省GL 2018、Auriemma JAMA Intern Med 2022、Tarcy ICM 2022、『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』

# 入院時は、推定意思の確認にとどめる

| | |
|---|---|
| **入口** | 蘇生の可否は聞かない。「**何か伺っていますか**」と、大事にしてきたこと・望まないことを聴く |
| **指示簿** | 「暫定フルコード（状況により随時検討）」と書き、話し合いの**進捗**を残す |
| **経過の中で** | 悪化の兆し・家族の問いで話し合い、**範囲の明確なDNAR**に落とす |

出典：厚労省プロセスGL（2018）、4学会合同ガイドライン（2026）

どう話すか

# 知らせの直後に、決めさせない

混乱や沈黙は、生理的な過負荷のサイン

聖路加国際病院 集中治療科

# 面談は5段階：説明の前に聴き、推奨は最後に

| | |
|---|---|
| **1 目的を伝え、許可を得る** | 「大切なことを伺いながら、一緒に考えたいのですが、よろしいですか」 |
| **2 理解と心配を聴く** | 「今一番心配なことは、どのようなことですか」 |
| **3 見通しを伝える** | 「残された時間が日単位〜週単位になっている可能性を心配しています」 |
| **4 大切なことを聴く** | 「普段の生活で一番楽しみにしていることは何ですか」 |
| **5 本人の言葉で推奨する** | 「○○が大切とおっしゃいましたね。それを考えると、◎◎をお勧めします」 |

**淡い段は、こちらが話す前に聴く段。本人に意識があれば、家族より先に本人に聞く**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編（言い方は要旨）、Kentish-Barnes ICM 2023

# 予後は「わかりません」で済ませず、時間の単位で

**「正確には分かりません。ただ、目安はお伝えできます」**

| 数時間〜数日 | **数日〜数週** | 数週〜数か月 | 数か月〜数年 |
|---|---|---|---|

- 聞く準備ができているかを先に確かめる
- 伝えたら**沈黙を置く**。気まずさから話し足さない

出典：『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』、4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編

# 決定の重荷を、家族に負わせない

言わない

「決めたのはご家族です」

こう言う

「医学的な結論を、ご家族と確認しました」

- 「死のタイミングに関わった」という**決定の残滓**は、正しい説明でも消えない
- 家族に選んでもらうのは、誰がそろうか・何時にするか。**良い記憶**として残る

出典：Choi Crit Care 2026、Kentish-Barnes ICM 2026

# 節目の面談と、議題のない日々の声かけ

| | 公式の家族面談 | 日々のcheck-in |
|---|---|---|
| **いつ** | 入室早期・TLTの期日・方針を変えるとき | 毎日、面会のたびに数分 |
| **議題** | あり。5段階を順に踏む | なし。**聴くことに徹する** |
| **出てくること** | 予後・方針・介入の可否 | お金・仕事・症状など医療の外の困りごと |

出典：Ashana ICM 2026、Cox CCM 2023

# 対立は3層で見立て、関係の層に入る前に手を打つ

## 課題

**「透析は続けるべきだ」**
何をすべきか。情報と
選択肢を整理する

→

## プロセス

**「そんな話、**
**聞いていません」**
誰がどう決めたか。
決め方と決定者を
明らかに

→

## 関係

**「この病院は**
**信用できない」**
信頼が壊れた。
第三者が要る

**「困った家族」と呼ぶ前に、どのプロセスが壊れていたかを見る**

出典：Jabaley Crit Care 2026、出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編

第 4 章

# 04

# DNARと蘇生

範囲は心停止時だけ。事前に決める

DNAR

# DNARは、
# 心停止時のCPRだけを決める

ほかの治療は、別に話し合って決める

聖路加国際病院 集中治療科

# DNARで決まること、決まらないこと

| | |
|---|---|
| **決まること** | 心停止時に、胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの**蘇生を試みない** |
| **決まらないこと** | 心停止前の挿管・人工呼吸・昇圧薬・血液浄化・ICU入室。目標と価値観に照らして**一つずつ**決める |
| **必ず行うこと** | 抗菌薬・酸素・非侵襲的換気・鎮痛鎮静・補液。DNARの有無にかかわらない |
| **しないこと** | 入院時の一律のDNAR、部分的DNAR（「心マだけ」）、スローコード |

> **「心停止」を「急変時」にすり替えない**

出典：日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、日本救急医学会 用語の統一概念（2025）、4学会合同GL Q37・Q39

# 「原疾患の心停止だけ」は成り立たない

**反論①**

心停止の原因は、その場では**分からない**。
発見するのは多くが看護師

**反論②**

DNARの根拠の多くは「CPRの利益がない」
という見込み。原因が分からなくても
**見込みは変わらない**

**文書の根拠**

原疾患に限ると定めた学会文書は
見当たらない。別の原因での心停止は
**事前に話し合え**とあるだけ

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、AHA 2025 倫理編

# フレイルは材料であって、結論ではない

## 医学の問い

蘇生がうまくいくか

- フレイルでCPR後死亡 OR 3.56（7研究）
- CFS 4超で生存退院 0／90例中
- CFSが高いほど神経学的転帰が悪い（日本）

## 価値の問い

この人にとって蘇生が最善か

- フレイルは答えない
- 年齢を唯一の決定因子にしない
- 価値観を引き出す方法がSDM

**閾値は研究ごとに違い、一律の線は引けない**

出典：Hamlyn Resusc Plus 2022、Ibitoye Age Ageing 2021、Yamamoto Ann Emerg Med 2023、AHA 2025 倫理編

# 価値の判断は事前に、現場では指示に従う

## 看護師（発見者）

- その場で価値観に立ち返らなくてよい
- 範囲が明確な指示に従う
- 曖昧で迷ったら、**蘇生を始めながら確認**

## 医師

- 事前に、価値観を聴いてから推奨する
- はい／いいえで選ばせない
- 結果を**範囲の明確な指示**にしておく

出典：AHA 2025 倫理編

# 窒息と医原性の心停止は、事前に合意した範囲で

| | |
|---|---|
| **窒息の苦しさ** | 異物除去や吸引はCPRではない。DNARと無関係に行う |
| **窒息後の心停止** | CPRをするかは、原因ではなく**事前に合意した範囲**で決まる |
| **処置に伴う心停止** | 可逆的で、処置への同意に回復が含まれうる。処置中にDNARを一時解除するかを**事前に決める** |

**指示は「原因を問わず・窒息を含む・処置は事前に」と範囲で書く（文例は最後の章）**

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）。範囲の書き方は一般論としての実装の一案

# 「すべて」は、処置に降ろして話す

**82.4%**
スローコードを「欺瞞」と判断した倫理文献

**67.6%**
「患者への害」と判断

**61.8%**
無益なCPRは断ってよい

- 「すべてやりますか」ではなく、「**胸骨圧迫・挿管・電気ショック**は、この方の目標の役に立つでしょうか」
- 短時間だけのCPRも、倫理的な妥協にならない

出典：Fontenot CCM 2026、Wasserman Crit Care 2026

第 5 章

# 05

# 差し控え・終了と緩和的抜管

同じ問いに答え、苦痛に先回りする

# 差し控えと終了は、同じ問いへの答え

**その治療は、いまの時点で本人にとって適切か**

### まだ始めていない → 差し控え

差し控えた後、**3人に1人**は生きて退院

### すでに始めている → 終了

終了した後、**98%**が24時間以内に亡くなる

**倫理的に同等。「やめられないから始めない」を
しない。臨床経過は別物なので記録で書き分ける**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）Q33・Q34、Ethicus-2（Sprung JAMA 2019）

# 3つの対応で、行うことと行わないことを分ける

| 対応 | 行うこと | 行わないこと |
|---|---|---|
| **差し控え** | 症状緩和の治療とケア | 新たな治療の開始と増強 |
| **終了** | 鎮痛・鎮静薬を続けて調整する | 呼吸器・補助循環・昇圧薬・<br>透析などを、**一つずつ**終える |
| **TLT** | 合意した期間、治療を試す | 期限で**自動的に**終了も<br>延長もしない |

**どれを選んでも症状緩和は最大限続け、心停止時のCPRは行わない**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）。強心薬・人工栄養・ペースメーカーも、何のために使っているかで一つずつ決める

# TLTは、目標・期日・価値観を先に書く

**目標**
人工呼吸から
離れて、
会話できる
状態に戻る

→

**期日と指標**
7日目に、
離脱の可否と
意識レベルで

→

**価値観**
「家族と
話せない状態で
長く生きる
ことは
望まない」

→

**期日で
立ち止まる**
改善なら継続、
未達なら終了も
含めて話す

**曖昧なまま続けると「決めきれないから続ける」になる。TLTは免罪符ではない**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）Q35、Quill JAMA 2011

緩和的抜管

# 準備を済ませ、苦痛に先回りする

緩和ケアは、終了の前から始まっている

聖路加国際病院 集中治療科

# 抜管の前日から、時刻を逆算する

| 24時間前 | 12時間前 | 2時間前 | 30分前 | 直前 | 抜管後 |
|---|---|---|---|---|---|
| **経管栄養を止める**<br>前日までに終えておく | **上気道浮腫が心配なら**<br>メチルプレドニゾロン<br>20 mg<br>4時間おき | **筋弛緩薬を止める**<br>多臓器不全では18時間前 | **分泌物が予想されたら**<br>ブチルスコポラミン<br>10〜20 mg<br>皮下注 | **苦痛に先回り**<br>オピオイドと鎮静薬の事前投与 | **そばを離れない**<br>落ち着くまで医師・看護師が調整 |

**筋弛緩薬が残っていると、苦しんでいても外から分からない**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編。12時間前・30分前・直前の投与は必要な患者に

# 死亡までは数分〜数日と、幅を持たせて伝える

### 段階的離脱

- 15〜30分かけて設定を下げ、自発呼吸へ
- 高度のサポートが要る呼吸不全で多い

### 即時抜管

- 準備を済ませ、設定を下げずに抜管
- 意識障害の患者で多い

- 死亡までは**数分から数日**と幅を持たせて伝える
- 死戦期呼吸・筋の攣縮・「思ったより長くかかること」を**先に言葉にしておく**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編、Kentish-Barnes ICM 2026

# 薬はボーラスで効かせ、オピオイドに上限を設けない

| 場面 | モルヒネ | フェンタニル | ミダゾラム |
|---|---|---|---|
| **未投与の初回** | 2〜5 mg 静注・皮下 | 20〜50 μg | 0.01〜0.06 mg/kg |
| **持続中の抜管直前** | 直近の効果量の2倍 | 直近1時間量の<br>25〜50% | 持続の1時間量 |
| **抜管後に苦しそう** | 10〜15分ごとに追加 | 5〜10分ごとに追加 | 5〜10分ごとに追加 |

**頻回に要るなら持続を始める・増やす。増量の意図は滴定のたびに記録する**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編 表1（米国の記事の改変・日本の用量の根拠ではない）。患者ごとに調整

# 症状を予測して、初手を先に打つ

## 初手

- 呼吸困難・痛み → オピオイドのボーラス
- 不安 → ミダゾラム
- 過活動型せん妄 → 抗精神病薬
- 気道分泌物 → 体位と輸液の減量。
  **家族への説明を添える**
- 上気道狭窄 → 抜管前のカフリークテスト

## しないこと

- 不安・せん妄に、鎮静目的のオピオイド
- 深い吸引（口腔内など浅く、愛護的に）
- 筋弛緩薬を残したまま抜管する

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編

第 6 章

# 06

# 看取り・チーム・公正

家族の時間を守り、医療者を守る

看取りと死別

# 最期の時間を、家族とともに守る

決める前から、亡くなった後まで

聖路加国際病院 集中治療科

# 家族のケアは、6つの時期で考える

1

**話し合いの前**
人となりを
聞き、
休める場を

2

**話し合いの間**
ずれは
否定せず、
様子を見て
もらう

3

**話し合いの後**
迷いは当然と
伝える

4

**終了の前**
数分〜数日と
幅を伝える

5

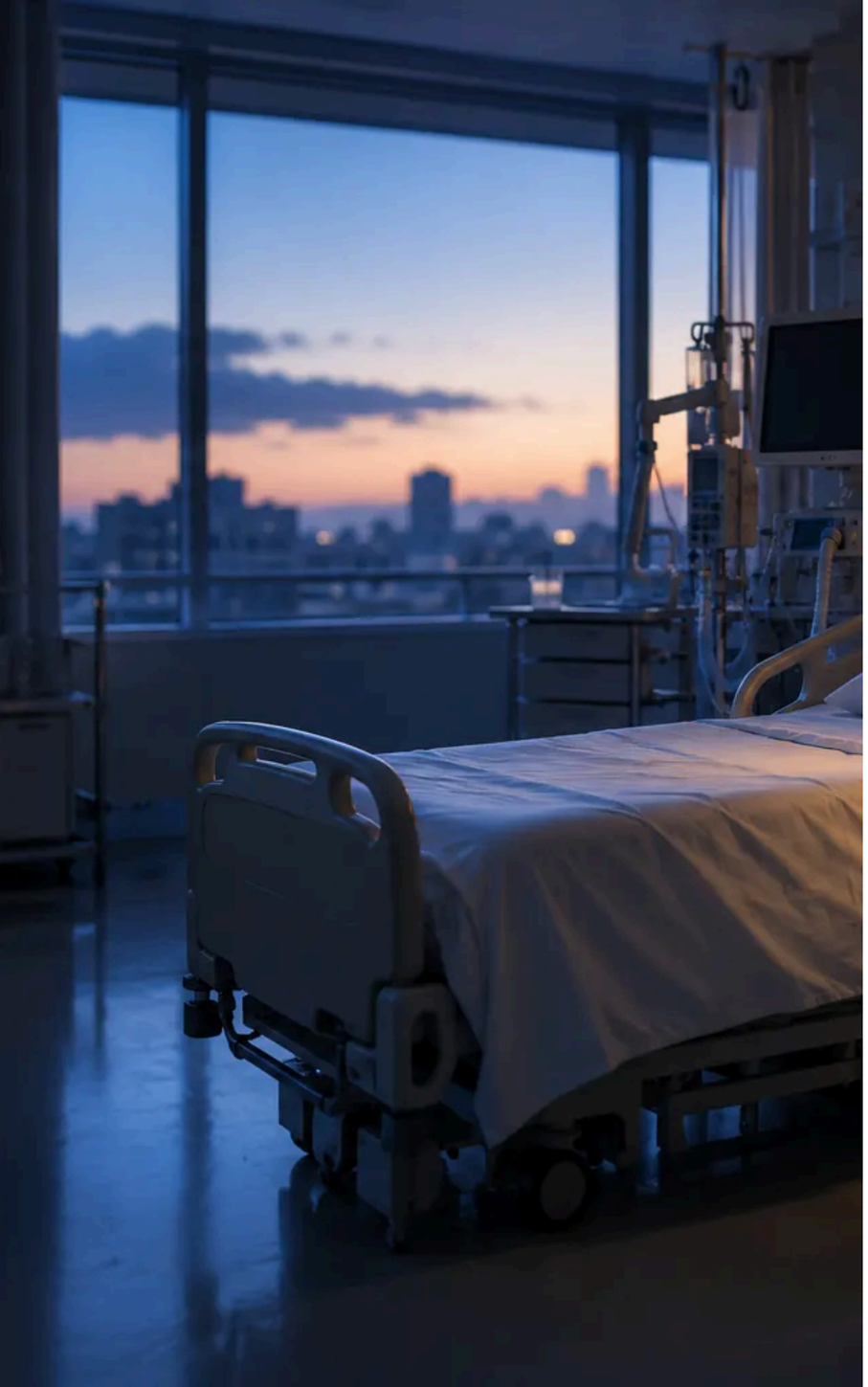
**臨終時**
音・におい・
汚れを整える

6

**死別後**
1〜2週後の
電話を検討

**死の前後に会う支援で、遷延性悲嘆が21%→15%。差の実体は死後の面談**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編、Kentish-Barnes Lancet 2022



# 死の判定と臓器提供は、手順を分ける

| | |
|---|---|
| 死亡確認 | 確かめているのは「戻せない」ではなく<br>「**もう戻さない**」という決定 |
| 順序 | 終了の判断が先、臓器提供の提示は後。<br>提供の可能性で終了を決めない |
| 家族 | 死亡告知と提供の依頼を**同じ**<br>**面談に入れない** |
| 脳死の言葉 | 「臓器を支える治療」と言い換え、<br>判定への立ち会いを選べるようにする |

出典：Le Dorze・Choi Crit Care 2026、4学会GL Q79、Wu JAMA 2026

# モラルディストレスは、組織の課題

## 増やす要因

- 「ノーと言えない」病院文化
- 医療の階層
- 治療を足す手続きはあるのに、**減らす手続きがない**

## 先に変える順番

- 看護師が単独で倫理・緩和コンサルを頼める
- 家族面談に看護師が同席する
- 終了条件を書面に残す
- **その次に**
  デブリーフィング

**デブリーフィングは緩和であって予防ではない。**
**書式を整えるだけでは風土は変わらない**

出典：Brender JAMA Netw Open 2025、CODE ICM 2024、4学会GL別編

# 年齢や障害で推し量らず、本人に尋ねる

1. 「普段使っているコミュニケーション手段は」
2. 「入院前は、何ができる状態でしたか」
3. 「この推奨は、**障害がなかったとしても同じ**ですか」

**ベッド状況・「無益性」・予後モデル・**
**障害だけを、判断の根拠にしない**

出典：Taccone ICM 2023、4学会GL Q47・Q70〜Q76、Beil ICM 2026

第 7 章

# 07

# 落とし穴と記録

結論だけでなく、範囲と過程を残す

# 良い意図が、言葉と順番の誤りで害に変わる

| よくある言葉・行動 | 代わりに |
| --- | --- |
| **DNARを理由に、心停止前の治療を控える** | 挿管・昇圧薬・ICU入室は別に話し合う |
| **「やめられないから始めない」** | 迷ったらTLTで始め、期日に見直す |
| **知らせの直後に「どうされますか」** | その場で決めさせず、翌日もう一度話す |
| **「決めたのはご家族です」** | 「医学的な結論をご家族と確認しました」 |
| **筋弛緩薬を残したまま抜管する** | 2時間前までに止め、苦痛に先回りする |
| **死亡告知と提供の依頼を続けて話す** | 間に時間を置き、担当を分ける |

**まだ分からない：4学会GLの手順が、患者・家族のアウトカムを改善するか**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）ほか

カルテ記載

# 結論だけでなく、範囲と過程を残す

DNARの有無だけでは、夜勤に伝わらない

聖路加国際病院 集中治療科

# 文例1：DNAR指示は、範囲で書く

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）

- 適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。
- 例外：**[内視鏡／CV挿入など]** 処置に伴う心停止の扱いは処置前に確認
- DNARを理由に控えない治療：酸素、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**[NIV]**
- 心停止前の治療（別に決定）：挿管 **[行う／行わない／TLT]**、透析 **[…]**
- 再評価：**[病状が変化したとき／○月○日／処置の前]**

［ ］は症例ごとに書き換える。施設の様式に合わせて直す

一般論としての文例。4学会GLが求める記録項目に沿う

# 文例2：面談記録は、過程を残す

1. 病状の説明
   見通し［数日〜数週］
   理解：「［家族の言葉］」
2. 本人の価値観
   「［本人の言葉・逐語］」
   推定の根拠：［以前の会話］
   → ゴール：［…］

3. 推奨と合意
   CPRを行わないと推奨
   形：［assent／nondissent］
   反応：［異議なし／保留］
4. 4観点の検討
5. 決定・保留・再評価日

一般論としての文例。参加者（本人・家族等・医師・看護師・ほか）と、検討に加わった全員も書く

# 文例3・4：TLTと、本人の意思によるDNAR

### 文例3 TLT

目的：［会話できる状態に戻ること］
治療：［人工呼吸／CRRT］
期間：［7日間］ 再評価 ［○月○日］
評価項目：［酸素化・昇圧薬・意識］
改善しないとき：［終了を含め
ゴールに沿って話し合う］

### 文例4 本人の意思によるDNAR

本人 ［意思決定能力あり：
4つの過程を確認］
「［本人の言葉］」
本人の価値観に基づく選択として
心停止時のCPRを行わない
家族等 ［氏名］ と共有 ［済／未］

一般論としての文例。終末期でなくても、本人には生命維持治療を選ぶ権利がある（4学会GL）

# 「急変時DNR」「家族が希望」だけを書かない

**「急変時DNR」「DNR取得」**
範囲が曖昧で、治療全般を
控える読み方を招く

**「家族がDNARを希望」だけ**
価値観・推定意思の
根拠・推奨がなく、何を
合意したか残らない

**重症度スコアを**
**制限の理由に**
予測は共有した情報、決定は
価値観と合意として書く

**DNAR指示の記録は9割、協議の過程の記録は7割（学会の調査）**

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、4学会合同ガイドライン（2026）

# まとめ：選ばせずに、医師から提案する

**価値観を聴いてから推奨する。強さは状況で変える。**
**提案と誘導を分けるのは、価値観を聴いたかどうか**

1

**「どうしますか」を、推奨に変える**
病状 → 価値観 → 推奨。決定の重荷を家族に負わせない

2

**DNARを範囲で書き、心停止前の治療は別に決める**
迷えば目標と期日を決めてTLTで試す

3

**終えるときは苦痛に先回りし、過程を記録に残す**
一人で決めず、チームも家族も支える

# ご清聴ありがとうございました

次の面談で、選ばせずに提案してみてください

聖路加国際病院 集中治療科

# 主な出典


- 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会. 生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）. 2026
- 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018
- 日本集中治療医学会. DNAR指示のあり方についての勧告. 2017／委員会報告. 2016／日本救急医学会. 高齢者救急に関する用語の統一概念. 2025
- Elmer J, et al. Part 3: Ethics. 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC. Circulation 2025
- Sprung CL, et al. JAMA 2019（Ethicus-2）／Curtis JR, et al. JAMA 2020／Lu E, et al. Mayo Clin Proc 2020／Secunda K, et al. JGIM 2020
- Ganzini L, et al. JAMDA 2004／Bein T, et al. ICM 2023／Taccone FS, et al. ICM 2023／Quill TE, et al. JAMA 2011
- Kentish-Barnes N, et al. Lancet 2022・ICM 2026／Jabaley CS, et al. Crit Care 2026／Choi・Le Dorze. Crit Care 2026／Wu. JAMA 2026
- Fontenot T, et al. CCM 2026／PICNL-ICU. CCM 2026／Brender TD, et al. JAMA Netw Open 2025／Hamlyn J, et al. Resusc Plus 2022
- 『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社 2024